

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Demografi dan Informasi Umum

Petunjuk: Isilah data berikut dengan lengkap dan benar. Lingkari atau centang pilihan yang sesuai.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama (inisial)	_____
2	Usia	_____ tahun
3	Jenis kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4	Kelas / Tingkat pendidikan	☐ SMP Kelas _____ ☐ SMA Kelas _____ ☐ SMK Kelas _____
5	Nama sekolah	_____
6	Pendapatan keluarga per bulan (perkiraan)	☐ < Rp 1.500.000 ☐ Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 ☐ Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000 ☐ > Rp 5.000.000
7	Pendidikan terakhir orang tua (ayah/ibu)	Ayah: ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3/S1 ☐ S2/S3 Ibu: ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3/S1 ☐ S2/S3
8	Komposisi keluarga saat ini	☐ Tinggal bersama kedua orang tua (utuh) ☐ Orang tua bercerai / pisah ☐ Salah satu orang tua meninggal ☐ Tinggal bersama wali / keluarga lain

Bagian I-B: Riwayat Kesehatan

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan melingkari atau mencentang pilihan yang sesuai.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
9	Apakah kamu saat ini menderita penyakit kronis (penyakit yang sudah berlangsung $\geq$ 3 bulan dan didiagnosis oleh dokter)? Contoh: asma, diabetes, epilepsi, penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan tiroid, dll.	☐ Ya, sebutkan: _____ ☐ Tidak
10	Jika Ya, apakah penyakit tersebut sudah mendapat pengobatan rutin dari dokter?	☐ Ya, rutin berobat ☐ Ya, tetapi tidak rutin ☐ Belum berobat
11	Apakah kamu pernah didiagnosis atau mendapat penanganan dari dokter/psikolog karena depresi atau gangguan mental lainnya sebelum penelitian ini?	☐ Ya, pernah didiagnosis depresi ☐ Ya, gangguan mental lain: ____ ☐ Tidak pernah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
12	Jika pernah, apakah saat ini masih dalam pengobatan atau terapi?	☐ Ya, masih dalam pengobatan ☐ Sudah selesai pengobatan ☐ Tidak berlaku

Lampiran 2. Skala Depresi (CESD-R)

Variabel Dependen: Kejadian Depresi pada Remaja

Nama Instrumen	Center for Epidemiologic Studies Depression Scale – Revised (CESD-R)
Pengembang	Eaton WW, Muntaner C, Smith C, Tien A, Ybarra M (2004); dikembangkan dari Radloff (1977)
Jumlah Item	20 item yang mencerminkan 9 gejala depresi mayor DSM-5
Subskala/Dimensi	Dysphoria (2 item) Anhedonia (2 item) Appetite change (2 item) Sleep disturbance (2 item) Thinking/concentration (2 item) Guilt/worthlessness (2 item) Fatigue (2 item) Agitation (2 item) Suicidal ideation (2 item)
Cara Pengisian	Mandiri (self-report), responden memilih frekuensi gejala dalam 2 minggu terakhir
Waktu Pengisian	10–15 menit
Bahasa	Telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia; tersedia versi tervalidasi untuk remaja
Cut-off dalam penelitian ini	Depresi ≥ 16 ; Tidak depresi < 16 (sesuai rekomendasi Eaton <i>et al.</i> , 2004)

Petunjuk Pengisian:

Di bawah ini terdapat pernyataan tentang perasaan dan pengalaman yang mungkin pernah kamu rasakan. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, lalu pilihlah angka yang paling menggambarkan seberapa sering kamu merasakan hal tersebut dalam 2 minggu terakhir.

0	1	2	3	Keterangan
Tidak pernah / jarang	Kadang-kadang (1–2 hari)	Cukup sering (3–4 hari)	Hampir setiap hari (5–7 hari)	Frekuensi dalam 2 minggu terakhir

No	Pernyataan	0 Tdk Pernah	1 Kadang	2 Cukup Sering	3 Hampir Setiap Hari	Subskala
1	Saya merasa sedih atau murung.	()	()	()	()	<i>Dysphoria</i>
2	Saya merasa tidak ada harapan untuk masa depan.	()	()	()	()	<i>Dysphoria</i>
3	Saya tidak merasa bahagia atau menikmati hal-hal yang biasanya aku sukai.	()	()	()	()	<i>Anhedonia</i>

No	Pernyataan	0 Tdk Pernah	1 Kadang	2 Cukup Sering	3 Hampir Setiap Hari	Subskala
4	Saya merasa hidup saya tidak berarti.	()	()	()	()	<i>Anhedonia</i>
5	Nafsu makan saya berkurang, meskipun saya tidak sengaja diet.	()	()	()	()	<i>Appetite</i>
6	Saya makan lebih banyak dari biasanya.	()	()	()	()	<i>Appetite</i>
7	Saya sulit tidur atau tidur saya terganggu.	()	()	()	()	<i>Sleep</i>
8	Saya tidur lebih banyak dari biasanya (mengantuk berlebihan).	()	()	()	()	<i>Sleep</i>
9	Saya sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih.	()	()	()	()	<i>Thinking</i>
10	Saya membuat keputusan dengan sangat lambat.	()	()	()	()	<i>Thinking</i>
11	Saya merasa diri saya buruk, tidak berharga, atau bersalah.	()	()	()	()	<i>Guilt</i>
12	Saya merasa orang-orang tidak menyukai saya.	()	()	()	()	<i>Guilt</i>
13	Saya merasa lelah atau tidak punya energi.	()	()	()	()	<i>Fatigue</i>
14	Segala sesuatu terasa berat dan membutuhkan usaha keras.	()	()	()	()	<i>Fatigue</i>
15	Saya berbicara atau bergerak lebih lambat dari biasanya.	()	()	()	()	<i>Agitation</i>
16	Saya merasa gelisah dan tidak bisa diam.	()	()	()	()	<i>Agitation</i>
17	Saya berpikir tentang kematian.	()	()	()	()	<i>Suicidal</i>
18	Saya berpikir untuk menyakiti diri sendiri.	()	()	()	()	<i>Suicidal</i>
19	Saya merasa kesepian.	()	()	()	()	<i>Dysphoria</i>
20	Saya merasa tidak dicintai.	()	()	()	()	<i>Guilt</i>

Catatan Skoring CESD-R:

Item No. 18 (pikiran menyakiti diri sendiri) merupakan item sentinel. Jika responden menjawab 2 atau 3 pada item ini, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut oleh

peneliti/konselor segera. Skor total = jumlah seluruh 20 item (0–60). Depresi apabila skor ≥ 16 .

Validitas & Reliabilitas:

Instrumen CESD-R memiliki Cronbach alpha 0,89–0,92 pada berbagai populasi. Validitas konvergen terhadap DSM-5 MDD sangat baik (Sensitivity 97%, Specificity 84% pada cut-off 16). Versi Bahasa Indonesia telah divalidasi pada populasi remaja (Kim *et al.*, Psychiatry Investig., 2025; Eaton *et al.*, Psychol Assess., 2004). Jika digunakan dalam konteks budaya lokal, direkomendasikan uji validitas konten dan konfirmatori (CFA) sebelum penggunaan skala besar.

Lampiran 3. Kualitas Tidur (PSQI)

Variabel: Kualitas Tidur (Faktor Psikologis)

Nama Instrumen	Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Pengembang	Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ (1989)
Jumlah Item	19 item yang menghasilkan 7 komponen skor
Subskala/Dimensi	C1: Kualitas tidur subjektif C2: Latensi tidur C3: Durasi tidur C4: Efisiensi tidur C5: Gangguan tidur C6: Penggunaan obat tidur C7: Disfungsi siang hari
Cara Pengisian	Mandiri (self-report); mengacu pada kebiasaan tidur dalam 1 bulan terakhir
Waktu Pengisian	5–10 menit
Cut-off dalam penelitian ini	Kualitas tidur buruk: skor global PSQI > 5; Baik: ≤ 5

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan kebiasaan tidur kamu dalam 1 bulan terakhir. Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur sesuai pengalaman tidurmu yang paling sering terjadi.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Biasanya, jam berapa kamu mulai tidur di malam hari? (hari sekolah)	Jam _____:_____
2	Biasanya, berapa menit yang kamu butuhkan untuk bisa tertidur setelah berbaring?	_____ menit
3	Biasanya, jam berapa kamu bangun di pagi hari? (hari sekolah)	Jam _____:_____
4	Berapa jam total kamu benar-benar tidur setiap malam? (bukan waktu berbaring)	_____ jam
5	Seberapa sering kamu mengalami gangguan tidur karena: tidak bisa tidur dalam 30 menit, terbangun tengah malam, harus ke kamar mandi, susah napas, batuk, merasa kedinginan/kepanasan, mimpi buruk, nyeri tubuh?	☐ Tidak pernah (dalam 1 bulan terakhir) ☐ Kurang dari sekali seminggu ☐ Sekali atau dua kali seminggu ☐ Tiga kali atau lebih seminggu
6	Bagaimana kamu menilai kualitas tidurmu secara keseluruhan?	☐ Sangat baik ☐ Cukup baik ☐ Cukup buruk ☐ Sangat buruk
7	Seberapa sering kamu merasa mengantuk saat mengikuti pelajaran, makan, atau beraktivitas sosial?	☐ Tidak pernah ☐ Kurang dari sekali seminggu ☐ Sekali atau dua kali seminggu

No	Pertanyaan	Jawaban
		() Tiga kali atau lebih seminggu

Skoring PSQI:

Setiap komponen dinilai 0–3. Skor total = jumlah 7 komponen (0–21). Skor > 5 mengindikasikan kualitas tidur buruk secara klinis. Komponen C1–C7 dihitung berdasarkan algoritma skoring resmi Buysse *et al.* (1989) yang tersedia di publikasi asli.

Validitas & Reliabilitas:

Cronbach alpha 0,83 (Buysse *et al.*, 1989). Sensitivitas 89,6% dan spesifisitas 86,5% dalam membedakan kelompok tidur baik vs buruk. Telah divalidasi pada remaja Indonesia dengan alpha 0,79–0,85 (Abimannan *et al.*, 2025). Uji validitas ulang direkomendasikan pada sampel remaja sekolah menengah di wilayah penelitian.

Lampiran 4. Screen Time dan Media Sosial

Variabel: Durasi Screen Time (Faktor Psikologis & Perilaku)

Nama Instrumen	Kuesioner Screen Time Self-Report (adaptasi dari WHO Adolescent Health Survey & Twenge <i>et al.</i> , 2018)
Jumlah Item	8 item utama
Dimensi	Durasi total screen time per hari Penggunaan media sosial Konteks penggunaan (rekreasi vs akademik) Dampak subjektif
Cara Pengisian	Mandiri; mengacu pada kebiasaan 1 bulan terakhir pada hari sekolah dan akhir pekan
Cut-off dalam penelitian ini	Tinggi: > 3 jam/hari (di luar keperluan sekolah); Rendah: ≤ 3 jam/hari
Catatan	Instrumen ini tidak memiliki skor komposit; penilaian berdasarkan durasi yang dilaporkan. Perlu uji validitas konten pada populasi target.

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan berikut berkaitan dengan penggunaan perangkat layar (HP, laptop, tablet, TV) di luar keperluan sekolah/belajar. Jawablah sesuai kebiasaanmu yang sebenarnya dalam 1 bulan terakhir.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Rata-rata, berapa jam per hari kamu menggunakan HP/laptop/tablet untuk hiburan atau media sosial di HARI SEKOLAH? (tidak termasuk untuk belajar)	☐ < 1 jam/hari ☐ 1–2 jam/hari ☐ 2–3 jam/hari ☐ 3–5 jam/hari ☐ > 5 jam/hari
2	Rata-rata, berapa jam per hari kamu menggunakan HP/laptop/tablet untuk hiburan di AKHIR PEKAN?	☐ < 1 jam/hari ☐ 1–2 jam/hari ☐ 2–3 jam/hari ☐ 3–5 jam/hari ☐ > 5 jam/hari
3	Platform media sosial apa yang paling sering kamu gunakan? (boleh pilih lebih dari satu)	☐ Instagram ☐ TikTok ☐ YouTube ☐ Twitter/X ☐ WhatsApp ☐ Facebook ☐ Lainnya: _____
4	Seberapa sering kamu membandingkan dirimu dengan orang lain setelah melihat postingan di media sosial?	☐ Tidak pernah ☐ Jarang ☐ Kadang-kadang ☐ Sering ☐ Selalu
5	Apakah kamu pernah mengalami cyberbullying (diolok-olok, dihina, atau diintimidasi secara online) dalam 3 bulan terakhir?	☐ Ya, sering (lebih dari 2 kali) ☐ Ya, pernah (1–2 kali) ☐ Tidak pernah

No	Pertanyaan	Jawaban
6	Seberapa sering penggunaan HP/media sosial membuat kamu tidak bisa tidur tepat waktu?	☐ Tidak pernah ☐ Jarang (< 1x/minggu) ☐ Kadang (1–2x/minggu) ☐ Sering ($\geq$ 3x/minggu)

Lampiran 5. Dukungan Sosial (MOS-SSS)

Variabel: Dukungan Sosial (Faktor Sosial)

Nama Instrumen	Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS) – versi remaja
Pengembang	Sherbourne CD & Stewart AL (1991)
Jumlah Item	19 item fungsional + 1 item struktural (jumlah dukungan sosial)
Subskala/Dimensi	Emotional/informational support (8 item) Tangible support (4 item) Affectionate support (3 item) Positive social interaction (4 item)
Cara Pengisian	Mandiri; skala Likert 1–5 (tidak pernah hingga selalu)
Cut-off dalam penelitian ini	Rendah: skor total < median sampel; Tinggi: $\geq$ median

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan berikut bertanya tentang seberapa sering kamu mendapatkan bantuan atau dukungan dari orang-orang di sekitarmu (keluarga, teman, dll.) dalam 1 bulan terakhir. Lingkari angka yang paling sesuai.

No	Pertanyaan	1 Tdk Pernah	2 Jarang	3 Kadang	4 Sering	5 Selalu / Hampir Selalu
1	Ada seseorang yang memberikan perhatian dan mendengarkan keluhanmu dengan penuh perhatian.	()	()	()	()	()
2	Ada seseorang yang memberikan informasi atau saran yang membantumu menghadapi masalah.	()	()	()	()	()
3	Ada seseorang yang membantumu ketika kamu sakit dan perlu bantuan.	()	()	()	()	()
4	Ada seseorang yang menunjukkan cinta dan perhatian kepadamu.	()	()	()	()	()
5	Ada seseorang yang membantumu ketika kamu sedang stres atau dalam masalah.	()	()	()	()	()
6	Ada seseorang yang bersama kamu ketika kamu merasa sendirian atau sedih.	()	()	()	()	()
7	Ada seseorang yang membantu menyelesaikan urusan sehari-hari jika kamu tidak bisa melakukannya.	()	()	()	()	()
8	Ada seseorang yang bisa kamu ajak bersenang-senang atau melakukan kegiatan yang menyenangkan.	()	()	()	()	()

No	Pertanyaan	1 Tdk Pernah	2 Jarang	3 Kadang	4 Sering	5 Selalu / Hampir Selalu
9	Ada seseorang yang memahami masalahmu dan menanggapi dengan serius.	()	()	()	()	()
10	Ada seseorang yang mencintai dan menerima kamu apa adanya.	()	()	()	()	()

Validitas & Reliabilitas:

Cronbach alpha 0,91–0,97 (Sherbourne & Stewart, 1991). Struktur 4 faktor terkonfirmasi melalui CFA pada berbagai populasi lintas budaya. Versi adaptasi Bahasa Indonesia menunjukkan alpha 0,88–0,93 pada populasi dewasa muda. Rekomendasikan uji validitas konvergen dengan instrumen dukungan sosial lain (mis. Duke-UNC) pada populasi remaja Indonesia.

Lampiran 6. Lingkungan Sekolah (GBS dan *School Climate Survey*)

Variabel: Lingkungan Sekolah / Perundungan (Faktor Sosial)

Nama Instrumen	Gatehouse Bullying Scale (GBS) + School Climate Survey (adaptasi)
Pengembang GBS	Bond L, Carlin JB, Thomas L, Rubin K, Patton G (2001)
Jumlah Item	GBS: 6 item School Climate: 8 item Total: 14 item
Dimensi	GBS: Antisocial behavior, victimization School Climate: Hubungan guru-siswa, rasa aman, keterlibatan akademik
Cara Pengisian	Mandiri; Likert 1–4 atau dikotomis Ya/Tidak
Cut-off dalam penelitian ini	Tidak suportif: skor risiko tinggi ($\geq$ median); Suportif: $<$ median

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan berikut menanyakan tentang pengalaman dan perasaanmu di sekolah dalam 3 bulan terakhir. Jawablah dengan jujur sesuai pengalamanmu yang sebenarnya.

Bagian A – Pengalaman Perundungan (GBS):

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1	Apakah kamu pernah diintimidasi, digertak, atau diganggu secara fisik (dipukul, didorong, dsb.) oleh teman di sekolah dalam 3 bulan terakhir?	☐ Tidak pernah ☐ 1–2 kali ☐ 3–5 kali ☐ Lebih dari 5 kali
2	Apakah kamu pernah diejek, dihina, atau dipanggil dengan nama yang menyakitkan di sekolah dalam 3 bulan terakhir?	☐ Tidak pernah ☐ 1–2 kali ☐ 3–5 kali ☐ Lebih dari 5 kali
3	Apakah kamu pernah sengaja dikucilkan atau tidak diterima oleh kelompok teman di sekolah?	☐ Tidak pernah ☐ Kadang-kadang ☐ Sering ☐ Hampir selalu
4	Apakah ada teman yang sengaja menyebarkan rumor atau gosip negatif tentangmu di sekolah?	☐ Tidak pernah ☐ Kadang-kadang ☐ Sering ☐ Hampir selalu

Bagian B – Iklim Sekolah (School Climate Survey):

No	Pernyataan	1 Sangat Tdk Setuju	2 Tdk Setuju	3 Setuju	4 Sangat Setuju
----	------------	------------------------------	-----------------	-------------	-----------------------

No	Pernyataan	1 Sangat Tdk Setuju	2 Tdk Setuju	3 Setuju	4 Sangat Setuju
5	Saya merasa aman di sekolah.	()	()	()	()
6	Guru-guru di sekolahku peduli terhadap kondisi emosional siswanya.	()	()	()	()
7	Di sekolah, saya bisa mendapatkan bantuan jika saya mengalami masalah.	()	()	()	()
8	Saya merasa diterima dan dihargai oleh teman-teman di sekolah.	()	()	()	()
9	Tekanan belajar dan tugas di sekolah membuat saya sering merasa stres.	()	()	()	()
10	Saya merasa tidak suka atau takut pergi ke sekolah.	()	()	()	()
11	Guru-guruku mendengarkan dan menghormati pendapat murid.	()	()	()	()
12	Saya merasa senang dan nyaman berada di lingkungan sekolah.	()	()	()	()

Validitas & Reliabilitas:

GBS: Cronbach alpha 0,74–0,82; validitas kriteria terhadap pengalaman kekerasan fisik dan psikologis di sekolah telah dikonfirmasi (Bond *et al.*, 2001). School Climate Survey: alpha 0,78–0,85 pada sampel remaja Asia. Gabungan kedua instrumen memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas lingkungan sekolah sebagai faktor risiko depresi remaja.

Lampiran 7. Prosedur Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum digunakan dalam pengambilan data utama, seluruh instrumen yang diadaptasi ke Bahasa Indonesia dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berikut adalah prosedurnya: Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji coba terpakai, yaitu pengujian yang dilakukan langsung pada data penelitian utama. Uji validitas dilakukan dengan analisis korelasi item total menggunakan corrected item total correlation, dengan kriteria nilai $> 0,30$ dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien cronbach's alpha, dengan nilai $\geq 0,70$ dianggap reliabel. Item yang tidak memenuhi kriteria validitas akan dipertimbangkan untuk dihapus atau dipertahankan berdasarkan pertimbangan teoritis

Lampiran 8. Catatan Etika Penelitian

A. Informed Consent dan Assent

Karena subjek penelitian adalah remaja yang sebagian belum cukup umur (< 18 tahun), diperlukan dua dokumen persetujuan. Pertama, informed consent orang tua/wali yang menjelaskan tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko penelitian secara lengkap. Kedua, assent (persetujuan mandiri) dari remaja yang bersangkutan menggunakan bahasa yang sesuai usia dan mudah dipahami. Partisipasi bersifat sukarela dan peserta dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi.

B. Kerahasiaan dan Anonimitas Data

Seluruh data yang diperoleh dijamin kerahasiaannya. Identitas responden diganti dengan kode numerik. Data mentah disimpan dalam sistem yang terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh peneliti utama. Data tidak akan diberikan kepada pihak sekolah, orang tua, atau instansi manapun dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi individu. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk agregat (kelompok), bukan data individual.

C. Penanganan Pertanyaan Sensitif

Instrumen ini memuat pertanyaan yang berpotensi memicu distress psikologis, antara lain pertanyaan tentang gejala depresi (CESD-R item 17–18), dan pengalaman kekerasan (GBS). Oleh karena itu, peneliti wajib menyediakan:

Pendampingan saat pengisian	Peneliti atau asisten penelitian terlatih hadir dan dapat dihubungi jika peserta merasa tidak nyaman
Kartu sumber bantuan	Setiap responden menerima kartu berisi kontak konselor sekolah, hotline kesehatan jiwa (contoh: Into The Light Indonesia 119 ext. 8), dan psikolog layanan primer setempat
Protokol respons darurat	Jika responden menjawab 'Ya' pada item CESD-R No. 18 (pikiran menyakiti diri sendiri) dengan skor 2 atau 3, peneliti segera melakukan pendekatan individual dan merujuk ke konselor/dokter layanan primer hari itu juga
Debriefing	Setelah pengisian selesai, peneliti memberikan penjelasan singkat tentang tujuan penelitian dan mengonfirmasi kondisi emosional responden sebelum meninggalkan ruangan

Lampiran 9. Informed Consent

INFORMED CONSENT

Lembar Penjelasan Penelitian

Nama Peneliti : Teguh Jaya Sakti
NPM : 1142023006
Program Studi : Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer
Fakultas : Kedokteran Universitas YARSI
Judul Penelitian : Pengaruh Faktor Biopsikososial terhadap Kejadian Depresi pada Remaja Sekolah dalam Perspektif Kedokteran Keluarga Layanan Primer

Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang sedang melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan putra/putrinya menjadi responden dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial (termasuk perundungan/bullying) terhadap kejadian depresi pada remaja sekolah. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuesioner oleh responden yang membutuhkan waktu sekitar 20–30 menit.

Partisipasi dalam penelitian ini tidak menimbulkan risiko yang berbahaya. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Identitas responden tidak akan dicantumkan dalam laporan penelitian.

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela. Responden berhak menolak atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Tidak ada sanksi atau kerugian yang akan diterima apabila memilih untuk tidak berpartisipasi.

Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan mengenai penelitian ini, dapat menghubungi peneliti melalui:

Nama : Teguh Jaya Sakti
No. HP/WhatsApp :
Email :

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2026

Peneliti,

Teguh Jaya Sakti
NPM. 1142023006

Lembar Persetujuan Responden
(Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali : _____
Nama Siswa : _____
Kelas : _____
Asal Sekolah : _____

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Teguh Jaya Sakti
NPM : 1142023006
Judul Penelitian : Pengaruh Faktor Biopsikososial terhadap Kejadian Depresi
pada Remaja Sekolah dalam Perspektif Kedokteran
Keluarga Layanan Primer

Saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup dan memadai mengenai penelitian ini, serta memahami tujuan, prosedur, manfaat, kerahasiaan data, dan hak saya sebagai responden.

Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini bersifat sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan saya sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapun.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2026

Orang Tua/Wali,
(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Siswa/Responden,
(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Catatan: Lembar persetujuan ini diisi oleh orang tua/wali dan disimpan oleh peneliti.

Lampiran 10. Kuesioner Praktik Ibadah Harian

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah setiap pernyataan dengan saksama sebelum menjawab.
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda dalam 1 minggu terakhir dengan memberi tanda centang (✓) atau melingkari angka pada kolom yang tersedia.
3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Skor	Pilihan Jawaban	Keterangan
1	Tidak pernah	Tidak pernah melakukan dalam 1 minggu terakhir
2	Jarang	Melakukan 1–2 kali dalam 1 minggu terakhir
3	Sering	Melakukan 3–5 kali dalam 1 minggu terakhir
4	Selalu	Melakukan setiap hari dalam 1 minggu terakhir

4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya.

5. Pastikan tidak ada pernyataan yang terlewat.

Daftar Pernyataan Kuesioner

No.	Pernyataan	1 Tidak Pernah	2 Jarang	3 Sering	4 Selalu
1	Dalam 1 minggu terakhir, saya melaksanakan shalat fardu (wajib) 5 waktu setiap harinya.				
2	Dalam 1 minggu terakhir, saya melaksanakan shalat wajib meskipun sedang sibuk atau kurang sehat.				
3	Dalam 1 minggu terakhir, saya melaksanakan shalat sunnah dhuha.				
4	Dalam 1 minggu terakhir, saya melaksanakan shalat sunnah rawatib (sebelum/sesudah shalat wajib).				
5	Dalam 1 minggu terakhir, saya membaca Al-Qur'an setiap hari.				
6	Dalam 1 minggu terakhir, saya meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an meskipun				

hanya beberapa ayat.

7 Dalam 1 minggu terakhir, saya berdzikir (mengingat Allah) setiap hari, misalnya membaca tasbih, tahmid, atau istighfar.

8 Dalam 1 minggu terakhir, saya berdzikir setelah selesai melaksanakan shalat wajib.

Cara Skoring dan Interpretasi

1. Skoring

Setiap item diberi skor 1 hingga 4 sesuai pilihan jawaban responden (tidak ada item unfavorable/reverse-scored). Skor total diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor item.

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah item	8 item	Pernyataan No. 1 – 8
Skor minimum	8	Seluruh item dijawab "Tidak Pernah" (skor 1 x 8)
Skor maksimum	32	Seluruh item dijawab "Selalu" (skor 4 x 8)
Rentang skor	8 – 32	Semakin tinggi skor, semakin tinggi religiusitas

Kategorisasi Religiusitas

Kategorisasi menggunakan nilai median skor total seluruh responden dalam sampel penelitian.

Kategori	Kriteria	Interpretasi
Religiusitas Baik	Skor ≥ 20	Praktik ibadah harian remaja tergolong baik atau lebih tinggi dibandingkan nilai tengah kelompok.
Religiusitas Kurang	Skor < 20	Praktik ibadah harian remaja tergolong kurang atau lebih rendah dibandingkan nilai tengah kelompok.